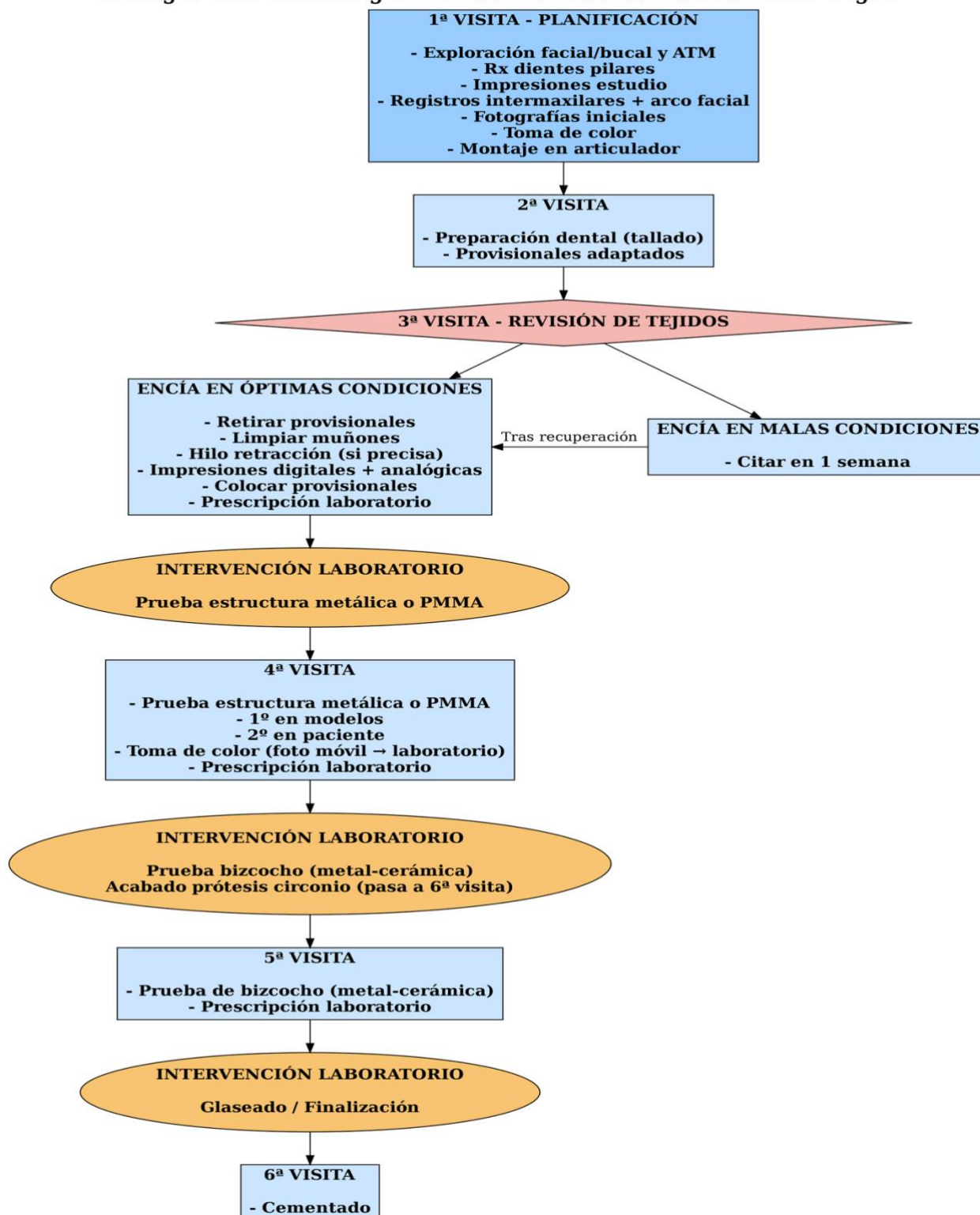




PROTOCOLO DE PRÓTESIS FIJA

Clínica Universitaria de Odontología

FLUJO DE TRABAJO - PROTOCOLO PRÓTESIS FIJA



INTRODUCCIÓN

La pérdida parcial de la dentición supone una pérdida de la función masticatoria, estética y oclusal por parte del paciente. Puede afectar psicológicamente al paciente, principalmente en los casos que hay una afectación estética.

OBJETIVOS

Recuperar las funciones anteriormente mencionadas y otras alteraciones biológicas como:

1. Pérdida de la función masticatoria, funcional y estética.
2. Alteración articular.
3. Posible disminución de la dimensión vertical.
4. Alteración perfil facial.
5. Disminución de la cresta ósea.

PROTOCOLO DE PRÓTESIS FIJA

1º VISITA - PLANIFICIACIÓN

1. DIAGNÓSTICO

- Historia clínica (médica y dental).
- Anamnesis y objetivos del paciente.
- Inspeccionar, si existen, prótesis fijas actuales.
- Inspeccionar tejidos blandos y duros intraorales (cresta ósea, cantidad reabsorción, lengua, musculatura...).
- ATM

2. ESTUDIO DEL CASO

a) Toma de impresiones:

1. Alginato de ambas arcadas (cubetas metálicas) + registro cráneomaxilar (arco facial) e intermaxilar:

- Oclusión estable: Máxima Intercuspidación.
- Oclusión inestable o disminución de la DVO: Relación Céntrica.

2. Escaneado digital (Medit)

b) Fotos del paciente: extraoral + intraoral + color (cámara fotográfica)

c) Radiografías: ortopantomografía y rx periapical para observar los dientes pilares (salud periodontal, presencia de caries, obturaciones presentes, vitalidad o no de la pieza, estado de la endodoncia si hubiera)

d) Montaje en articulador: Usamos montaje en articulador para observar distancias interoclusales, espacio entre dientes pilares, inclinaciones dientes pilares, tamaños de las coronas clínicas.

3. EXPLICACIÓN DEL CASO AL PACIENTE

- Explicaremos al paciente la solución encontrada a su caso según el estudio de los modelos.
- Comentaremos los distintos materiales que podemos utilizar: metal-cerámica, resinas, cerómeros, zirconio..., así como sus ventajas e inconvenientes.
- Explicaremos número de visitas a realizar (aproximadamente).

2ª VISITA

1. PROVISIONALES + LLAVE DE SILICONA

- Realizar los provisionales con técnica directa con llave de silicona usando cubeta parcial de asa móvil.
- Realizar llave de silicona para control volumen tallado

2. PREPARACIÓN DENTAL

- Anestesiar los dientes que vamos a tallar: infiltrativa o troncular.
- Realizar el tallado de la/s pieza/s a realizar:

Técnica de tallado:

- Tener en cuenta el material a realizar la prótesis, para diseñar el tallado de los márgenes según el material):
 - Metal/cerámica: escalón (90º)
 - Cerámica ó Zirconio: escalón (90º)
- Reducir la cara oclusal del diente entre 1.5 y 2 mm (depende del material a usar). Seguir la anatomía oclusal dental.
- Reducir las caras interproximales: Usar primero una fresa de rotura de punto de contacto para evitar contactar con la pieza vecina. Posteriormente, podemos usar una fresa troncocónica para reducción axial de 1 a 1.5 mm.
- Colocar hilo retráctil nº 2 con el instrumento Fischer o espátula de composite para provocar una retracción de la encía, y así ganar seguridad al separar la encía y evitar lesionarla pudiendo diseñar los márgenes subgingivales.
- Repasar todas las caras dentales y márgenes con fresa de pulido.

Nota:

- El alumno debe ser consciente de sus limitaciones técnicas y por ello no deberá de tallar más de 2 dientes al día.
- Según evolución del alumno, el profesor podrá indicar la realización de sucesivas prótesis con un tallado marginal en chamfer.
- La realización del provisional tendrá que iniciarse a las 6:30h como tarde

3. REALIZACIÓN DE PROVISIONALES Y CEMENTADO

- Se realiza con la técnica directa.
- Pulir los márgenes de los provisionales con discos de pulir (Sof-lex).
- Cementaremos los provisionales con un cemento temporal (TempBond sin eugenol) y eliminaremos el sobrante del cemento (sonda e hilo dental para las zonas interproximales)
- Comprobación final del ajuste oclusal.

3ª VISITA

1. IMPRESIONES DEFINITIVAS

La semana siguiente a la finalización del tallado si la encía del contorno de las preparaciones esta en correctas condiciones, realizaremos la toma de impresiones digitales con nuestro escáner "Medit" (ver video de escaneado y pdf) + impresiones analógicas con siliconas. Si el estado de salud de la encía no es adecuado se citará al paciente en una semana.

Ponemos el hilo de retracción del nº1 ó nº2 (según tipo de encía) y después colocamos la silicona fluida en la preparación y en la cubeta, la cual nuestro ayudante tendrá colocada la silicona pesada (Técnica de una fase "*doble mezcla una impresión*")

En el caso de que se necesite una cubeta individual para las impresiones analógicas, aplicaríamos a la cubeta un adhesivo (VPS TRAY ADHESIVE DE 3M) que nos ayuda a la adhesión del material en la cubeta.

2. CEMENTACIÓN DE PROVISIONALES Y COMPROBAR SU AJUSTE

- Comprobar en boca el buen ajuste marginal, oclusal y puntos de contacto.
- En caso necesario valorar su rebasado con un composite fluido si es por técnica directa y con resina autopolimerizable si son de laboratorio
- Cementaremos los provisionales con un cemento temporal (TempBond sin eugenol) y eliminaremos el sobrante del cemento (sonda e hilo dental para las zonas interproximales)
- Comprobación final del ajuste oclusal.

3.PRESCRIPCIÓN AL LABORATORIO: Rellenar la prescripción de laboratorio en el Medit indicando (ver pdf y video explicativo):

- trabajo a realizar y material a usar
- Número de historia clínica – albarán de pago – alumno prescriptor
- Día de entrega
- Prueba para realizar en la próxima visita
- Características concretas de ese trabajo.

Nota:

- El alumno debe RECORDAR que el paciente ha de pagar en esta cita la prótesis íntegramente incluido el escaneado intraoral para poder ser enviado al laboratorio

4ª VISITA

1. PRUEBA DEL METAL O PMMA (PRUEBA PLÁSTICA)

Se comprueba la prueba de metal ó la prueba de PMMA en modelo y posteriormente en el paciente :

- Se retirará el provisional.
- Limpiar con torunda de algodón los muñones dentales.
- Colocar la estructura en boca comprobar:
 1. Adaptación: fricción tenue + ajuste pasivo
 2. Adaptación marginal: sellado marginal (Usar sonda de exploración para comprobar)
 3. Ausencia de poros y defectos.
 4. Ajuste RX (si fuera necesario)

Si todo es correcto, escogeremos el color (guia Vita Clasica o 3DMaster Vita) y se realizarán fotos intraorales y del color para enviarlas al WhatsApp laboratorio con el móvil de la CLUO.

- Recementaremos el provisional con cemento temporal.
2. **PRESCRIPCIÓN AL LABORATORIO:** Rellenar la hoja de laboratorio para prueba de bizcocho o el acabado del Zirconio indicando el **color** y la foto enviada al WhatsApp del laboratorio.

Nota: Las fotos enviadas por WhatsApp deben contener el número de historia del paciente para que el laboratorio sepa a que paciente pertenecen

5ª VISITA

- Se citará al paciente para la prueba del bizcocho en caso de prótesis metal-cerámica. En caso de circonio se pasaría a la cita de cementado directamente.
- Se retira el provisional limpiando los muñones con torunda de algodón.
- Se comprobará ajuste marginal, puntos de contacto, oclusión y color.
- Verificar puntos de contacto con hilo o seda dental:
 - Si es excesivo, interponer papel de articular de 40 μm en el punto de contacto, y retocar zona marcada por el papel, hasta conseguir un buen punto de contacto.
 - Si no existe, verificar que en el modelo tampoco existe y tomar una impresión de arrastre del bizcocho ó un nuevo escaneado digital.
- Se rectificará la oclusión y determinará cambios en el color si fuera necesario (hacer fotos para enviar al laboratorio indicando los cambios tanto en la prescripción como en la foto al enviarla por WhatsApp)
- Recementar el provisional.
- Rellenar la hoja de laboratorio: especificar cambios a realizar o/y terminado.

6ª VISITA

- Se citará al paciente para la cementación definitiva de la prótesis.
- Se retira el provisional limpiando los muñones con torunda de algodón.
- Se hará una última comprobación de la prótesis.
- Se cementará la prótesis con cemento definitivo GC Fuji I o II ó ketac Cem en caso de metal-cerámica y en caso de zirconio ó cerámica Variolink.
- Eliminar el sobrante de cemento.
- Comprobar oclusión y puntos de contacto.
- Citar al paciente una semana después para revisión y fotos finales.